

ความโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Loneliness of elderly in the epidemic situation of Coronavirus Disease 2019

พัชรารภณ์ โปโก* ศากุล ช่างไม้** และสุปราณี แต่งวงษ์**

Patcharaphon Poko, * Sakul Changmai, ** and Supranee Tangwong**

*คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร

**คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

*Faculty of Nursing, Shinawatra University

**College of Nursing, Christian University of Thailand

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนาเจาะลึกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวิธีการเผชิญความโดดเดี่ยว ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ความโดดเดี่ยว จำนวน 13 ราย เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบประเมินความโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุ แบบประเมินภาวะสมองเสื่อม และกรอบคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งพัฒนาโดยผู้วิจัย เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจนข้อมูลมีความอิ่มตัว ผลการวิจัยพบว่า ความโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุเป็นความรู้สึกเหงา ต้องอยู่บ้านตามลำพัง ไม่สามารถไปเยี่ยมบุตรหลานได้ เสมือนว่าขาดการติดต่อกันจนขาดคู่คิด และไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่เคยทำได้ การเผชิญความโดดเดี่ยวเป็นการกระทำที่ใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ ได้แก่ ใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ในตนเองแก้ปัญหา ยอมรับที่ต้องอยู่บ้านแม้รู้สึกอึดอัด หากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำ ใช้โทรศัพท์/ วิดีโอคอล เพื่อสื่อสารกับคนในครอบครัว และแนะนำบุตรหลานตรวจหาเชื้อโควิดก่อนมาพบกัน นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้สูงอายุมีวิธีในการสร้างความสุขด้วยตนเองแม้มีสถานการณ์ของโรคระบาดเกิดขึ้น

คำสำคัญ: ความโดดเดี่ยว, ผู้สูงอายุ, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ได้รับทุนวิจัยจากมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมณฑาทิพย์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2565

Corresponding author E-mail: patcharaphonpo@hotmail.com

วันที่รับบทความ: 4 มกราคม 2568 วันที่แก้ไขบทความ: 28 เมษายน 2568 วันที่ตอบรับบทความ: 28 เมษายน 2568

สังคม ด้วยคำในตนเอง รู้สึกไม่เป็นที่ต้องการของสังคม ทำยที่สุด นำไปสู่การลดความสัมพันธ์กับผู้อื่น และการแยกตัวออกจากสังคมมากขึ้น ดังนั้นในบริบทของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากความโดดเดี่ยวอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อและมีข้อจำกัดทางสุขภาพ จึงมักได้รับคำแนะนำให้อยู่ภายในที่พักอาศัยเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม จึงยังทำให้การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นลดลง และเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความโดดเดี่ยวเพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุ

จากการศึกษาที่ผ่านมาเรื่องความโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุไทยในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศยังพบว่ามีจำนวนน้อย เช่น เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุไทยช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า 1 ใน 4 ของผู้สูงอายุมีอาการทางสุขภาพจิตเกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งอาการ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2563) ส่วนในต่างประเทศ Heindinger และ Richter (2020) พบว่า ระดับความโดดเดี่ยวในผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากผลของมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นมาตรการหลักด้านความปลอดภัยในการป้องกันโรค ขณะที่การศึกษาของ Kasar และ Karaman (2021) ชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังและมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำ มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะโดดเดี่ยว และมีคุณภาพชีวิตที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นในสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 คน พบว่า มีผู้สูงอายุจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 ที่มีคะแนนความโดดเดี่ยวอยู่ในระดับปานกลาง สะท้อนให้เห็นว่าความโดดเดี่ยวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน แม้ในบริบทที่มีการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องในชมรมผู้สูงอายุ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ชมรมต้องหยุด

กิจกรรม ส่งผลให้สามารถศึกษาและเข้าใจผลกระทบจากการลดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของการศึกษาประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่เผชิญภาวะโดดเดี่ยวนี้เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลและสนับสนุนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดโรคอุบัติใหม่ในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย

ศึกษาความโดดเดี่ยวและวิธีการเผชิญความโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วิธีดำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนาเจาะลึก (Exploratory descriptive qualitative research [EDQ]) ของ Hunter และคณะ (2019)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีภูมิลำเนาตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 13 ราย เลือกแบบเจาะจง โดยเป็นผู้สูงอายุที่มีคะแนนความโดดเดี่ยวปานกลาง คือ 41-60 คะแนน (รพีพรรณ สารสมิคร, 2561) ตามแบบประเมิน University of California, Los Angeles Loneliness scale version 3 (UCLA) แปลโดยทินกร วงศ์ปการันย์ และณัทย วงศ์ปการันย์ (2563) และมีคุณสมบัติดังนี้ 1) มีการรับรู้ บุคคล เวลา สถานที่ที่เกิดไม่มีภาวะสมองเสื่อมเมื่อประเมินด้วยแบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น (Thai Mental State Examination) 2) การได้ยินปกติและสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ และ 3) ไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีโรคทางจิต

การเก็บข้อมูลสิ้นสุดเมื่อข้อมูลที่ได้มีความอิ่มตัว (data saturation) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล

จำนวน 13 ราย พบว่า ข้อมูลที่ได้รับมีความครบถ้วน ครอบคลุม และเพียงพอต่อการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ไม่มีข้อมูลหรือประเด็นใหม่เกิดขึ้น การตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation) (Guba & Lincoln, 1989) ตามแนวคิดความโดดเด่นในตัวผู้สูงอายุของ Peplau และ Perlman (1998) พบว่าข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้องกับแนวคิดโดยเฉพาะเรื่องความคาดหวังกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ของการระบาดครั้งนี้ ทั้งนี้จำนวนผู้ให้ข้อมูล 13 รายเป็นไปตามหลักการของ Hunter และ คณะ (2019) ที่ระบุว่างานวิจัยเชิงคุณภาพแบบ EDQ สามารถใช้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีจำนวนไม่เกิน 15 รายได้ หากข้อมูลมีความอิ่มตัว

เครื่องมือวิจัย

1. **แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล** ใช้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สมาชิกในครอบครัว โรคประจำตัวและการเจ็บป่วย การร่วมกิจกรรมทางสังคมและการได้รับวัคซีน

2. **แนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก** เป็นชุดคำถามที่จัดเตรียมไว้ตามลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย คำถามหลัก (main question) เช่น "เมื่อพูดถึงคำว่า 'โดดเดี่ยว' ท่านนึกถึงอะไร" คำถามติดตาม (follow up) เช่น "ท่านคิดว่าคนที่มีความโดดเดี่ยวจะรู้สึกแบบไหน" คำถามล้วงลึก (probe) เช่น "ท่านเคยรู้สึกโดดเดี่ยวบ้างไหม เล่าความรู้สึกตอนนั้นให้ฟังหน่อย" "เหตุการณ์ใดที่ทำให้ท่านรู้สึกเช่นนั้น" "ความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นมีผลอย่างไรกับชีวิตของท่าน" และ "ท่านจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นอย่างไร และผลเป็นอย่างไร" แนวคำถามเหล่านี้ถูกออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล

คุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก จึงมีการเตรียมความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพและการสัมภาษณ์โดยผู้วิจัย

ลำดับที่ 1 ได้ศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ และฝึกเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพภายใต้การดูแลของผู้วิจัยคนที่ 2

กรอบคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการพยาบาลผู้สูงอายุ จำนวน 3 ท่าน พิจารณาความชัดเจน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการใช้เก็บข้อมูล จากนั้นจึงนำแบบคำถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 3 ราย เพื่อประเมินความเข้าใจ ความสั้นไหลของคำถาม และการนำไปใช้จริง ก่อนดำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนต่อไป

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โครงการวิจัยได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ บ. 21/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลได้จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รวมทั้งได้ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่าหากเข้าร่วมการวิจัยแล้วสามารถถอนจากการวิจัยได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผล และจะไม่มีผลใดๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยมีการใช้รหัสแทนชื่อจริงของผู้สูงอายุแต่ละราย และการนำเสนอข้อมูลเป็นภาพรวมของผลการวิจัย และเมื่อสิ้นสุดโครงการข้อมูลทุกอย่างจะถูกทำลายทิ้ง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 และดำเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ตามขั้นตอนดังนี้

ผู้วิจัยติดต่อผู้สูงอายุเพื่อนัดหมาย วัน เวลา สัมภาษณ์ที่บ้านของผู้สูงอายุ สำหรับการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ 3 รายแรก ดำเนินการสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยทั้ง 2 คนร่วมกัน จากนั้น ผู้วิจัยลำดับที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ในรายที่เหลือ การสัมภาษณ์แต่ละรายใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที 1-2 ครั้งต่อรายเพื่อให้ได้ข้อมูล

สมบูรณ ในการสัมภาษณ์มีการบันทึกเสียงระหว่างผู้วิจัยกับผู้สูงอายุ โดยผ่านการอนุญาตจากผู้สูงอายุ และมีการจดบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด มีการสังเกตบันทึกปฏิกิริยาพฤติกรรมของผู้สูงอายุในระหว่างทำการสัมภาษณ์ไปพร้อมกัน จากนั้นผู้วิจัยดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงประเด็น (thematic analysis) โดยการถอดเทปเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นเคยกับข้อมูล จากนั้นจัดกลุ่มของข้อมูลเป็นหมวดหมู่ แล้วค้นหาประเด็นที่เกิดขึ้นและมีความเกี่ยวข้องกัน ทบทวนเป็นประเด็นต่าง ๆ ตั้งชื่อประเด็นและกำหนดความหมายหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้น รวมทั้งมองหาประเด็นย่อยของประเด็นหลักนั้น ๆ จนมั่นใจว่าได้ข้อมูลที่อิมตัว (สุภาภรณ์ สุธหนองบัว, 2564; Braun & Clarke, 2006)

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาความโดดเดี่ยวและวิธีการเผชิญความโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 จากการศึกษาพบประเด็นความโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 และวิธีการเผชิญความโดดเดี่ยวและสถานการณ์อื่นจะนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาความโดดเดี่ยวและการสร้างความสุขของผู้สูงอายุดังต่อไปนี้

1. ความโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุ สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านตามลำพังและจำกัดการเดินทาง ส่งผลให้เกิดความรู้สึก “โดดเดี่ยว” อย่างเด่นชัด ผู้ให้ข้อมูลสะท้อน **ความหมายของความโดดเดี่ยว** ออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ดังนี้

1.1 ความเหงาและความรู้สึกโดดเดี่ยวจากการอยู่คนเดียว: ผู้สูงอายุจำนวนมากสะท้อนความรู้สึกว่าการต้องอยู่บ้านตามลำพัง ทำให้เกิดความรู้สึกเหงา ขาดความ

มีชีวิตชีวา และไร้ความหมายในชีวิตประจำวัน ดังคำพูดต่อไปนี้ “ไม่ได้ไปไหนเลย เหงามากตอนนั้นจะไปหาเพื่อนก็ไม่ได้ ” (ผู้ให้ข้อมูล 02) “ อยู่คนเดียวหลายสิบปี ลูกต้องทำมาหากิน ” (ผู้ให้ข้อมูล 11)

1.2 การขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด การพบปะผู้คนถูกจำกัดอย่างมาก ส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก แม้จะมีคนอยู่ร่วมบ้าน แต่หากขาดการสื่อสารก็ยังคงรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ดี ดังคำพูดต่อไปนี้ “ ช่วงโควิดเราไปไหนไม่ได้ หาเพื่อนก็ไม่ได้ ” (ผู้ให้ข้อมูล 02) “ ออกไปไหนไม่ได้เลย อยู่กับแฟนแต่ไม่ได้คุยกันก็เหงา ” (ผู้ให้ข้อมูล 02) และ “ ไม่ได้ออกไปพบปะใครเลย เหมือนโดนตัดขาด ” (ผู้ให้ข้อมูล 03)

2. ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุทั้งด้านสังคม อารมณ์ความรู้สึก และเศรษฐกิจ ความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นได้สะท้อนออกมาในรูปแบบของผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิตและความรู้สึกของผู้สูงอายุ จำแนกออกได้เป็น 3 ประเด็นย่อย ดังนี้

2.1 ผลกระทบด้านสังคม ผู้สูงอายุรู้สึกว่าความสัมพันธ์ทางสังคมลดลง ไม่สามารถพบปะเพื่อนฝูงหรือสมาชิกในครอบครัวได้เหมือนเดิม ดังคำพูดต่อไปนี้ “ เพื่อนฝูงจะไปมาหาสู่กันน้อยลง ” (ผู้ให้ข้อมูล 01) และ “ ไม่ได้ออกตลาด ไม่ได้ไปพบคนเหมือนเดิม ” (ผู้ให้ข้อมูล 08)

2.2 ผลกระทบด้านอารมณ์ความรู้สึก ความโดดเดี่ยวในช่วงโควิด-19 ส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกอึดอัดวิตกกังวล และขาดความอิสระในการใช้ชีวิต ดังคำพูดต่อไปนี้ “ เหงาขึ้นมาเราก็กุ้ยกับใครไม่ได้ บางทีมันก็เครียด ” (ผู้ให้ข้อมูล 02) “ เครียด ไม่อิสระ อยากไปไหนก็ไม่ได้ไปอย่างใจ ” (ผู้ให้ข้อมูล 03) และ “ มันรู้สึกอึดอัด อยากออกไปแต่ไปไหนไม่ได้ ” (ผู้ให้ข้อมูล 04)

2.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การจำกัดการเดินทางและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบด้านรายได้ รวมถึงขาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ดังคำพูดต่อไปนี้ “ รายได้ก็ลดลง ชัดไปหมด จะไปไหนก็ลำบาก ” (ผู้ให้ข้อมูล 08) และ “ เดียวนี้โรงงานก็ไม่ได้ไป ไม่ได้ชวนใครทำบุญเหมือนแต่ก่อน ” (ผู้ให้ข้อมูล 09)

3. วิธีการเผชิญความโดดเดี่ยวในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าผู้สูงอายุที่ประสบภาวะโดดเดี่ยวได้พยายามเผชิญสถานการณ์ด้วยวิธีการหลากหลายโดยใช้ทั้งประสบการณ์ชีวิตเดิม การทำกิจกรรมที่บ้าน การสื่อสารกับครอบครัว รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อรักษาสภาวะจิตใจและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ดังนี้

3.1 การใช้ประสบการณ์และความสามารถเดิมในการปรับตัว ผู้สูงอายุบางรายได้นำประสบการณ์จากบทบาทรุ่นที่เดิม เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข หรือความรู้ด้านสุขภาพ มาช่วยปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ ดังคำพูดต่อไปนี้ “ เราเป็น อสม. มีวิธีคิดในการช่วยดูแลลูกและป้องกันตนเอง ” (ผู้ให้ข้อมูล 01) และ “ ตอนนั้นไม่ได้เครียด เพราะเรามีประสบการณ์ในการดูแลตัวเอง ” (ผู้ให้ข้อมูล 05)

3.2 การทำกิจกรรมที่บ้านเพื่อลดความเหงา การทำงานบ้าน ปลูกต้นไม้ หรือดูแลหลานเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุเลือกทำเพื่อผ่อนคลาย ลดความรู้สึกเหงา และสร้างความรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า ดังคำพูดต่อไปนี้ “ ปลูกต้นไม้ ถางหญ้าให้หายเบื่อ ” (ผู้ให้ข้อมูล 08) “ อยู่บ้านเลี้ยงหลาน ถางหญ้า ทำกับข้าว ” (ผู้ให้ข้อมูล 07) และ “ อยู่กับหลาน ทำกิจกรรมช่วยบ้าน ” (ผู้ให้ข้อมูล 09)

3.3 การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร แม้ไม่สามารถพบหน้ากันได้ ผู้สูงอายุยังคงใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์และวิดีโอคอล เพื่อรักษาการสื่อสารและความ

สัมพันธ์กับคนใกล้ชิด ดังคำพูดต่อไปนี้ “ ได้แต่โทรคุยกับลูกเพราะมาไม่ได้ ” (ผู้ให้ข้อมูล 02) “ มีโทรศัพท์ก็คุยกันกับเพื่อนบ้าง ” (ผู้ให้ข้อมูล 03) และ “ โทรไปสั่งกับข้าว เขาก็เอามาแขวนหน้าบ้าน ” (ผู้ให้ข้อมูล 07)

4. การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแม้อยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 นอกจากการต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวและข้อจำกัดทางสังคม แต่ผู้สูงอายุหลายรายสามารถสร้างความสุขให้ตนเองได้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางศาสนา การช่วยเหลือผู้อื่น และการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ดังนี้

4.1 การทำบุญและกิจกรรมทางศาสนา การสวดมนต์ ฟังธรรมะ และไปวัด เป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุใช้สร้างความสงบในใจ และคลายความเครียด ดังคำพูดต่อไปนี้ “ ถ้าไม่ได้ไปวัด ก็สวดมนต์ ฟังเทศน์อยู่บ้าน ” (ผู้ให้ข้อมูล 06) และ “ ไปทำบุญทุกวันพระ ถ้าไม่ได้ไปไหน ” (ผู้ให้ข้อมูล 09)

4.2 การให้ความช่วยเหลือชุมชนและเห็นคุณค่าตนเอง ผู้สูงอายุบางรายยังคงมีบทบาทช่วยเหลือครอบครัวและชุมชน เช่น แจกของหรือทำหน้าที่อาสาสมัคร ซึ่งช่วยให้รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ดังคำพูดต่อไปนี้ “ เวลาเขาแจกของชาวบ้าน เราก็ช่วยเขาขนของไปวางหน้าเดินท์ ถึงจะไม่ได้ทำเยอะ แต่เราก็ช่วยเท่าที่ไหว ” (ผู้ให้ข้อมูล 06) และ “ ช่วงโควิดเราเป็น อสม. ต้องช่วยแจกของให้ชาวบ้าน ถึงจะเหนื่อยแต่เราก็เต็มใจทำ เพราะเป็นหน้าที่เรา ” (ผู้ให้ข้อมูล 10)

4.3 การดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียง ผู้สูงอายุหลายคนเน้นการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ปลูกผัก ทำอาหาร และดูแลบ้าน เพื่อสร้างความสุขในวิถีชีวิตที่ตนเองควบคุมได้ ดังคำพูดต่อไปนี้ “ ไม่ได้ทำอะไรมาก แต่อยู่ได้ มีพอแล้ว ” (ผู้ให้ข้อมูล 03) และ “ อยู่บ้านปลูกผัก ทำกับข้าวเอง ” (ผู้ให้ข้อมูล 09)

จากผลการวิจัยที่ได้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุ

สามารถเผชิญภาวะโดดเดี่ยวและสร้างความสุขในช่วงวิกฤตได้ด้วยแนวทางที่หลากหลายและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง โดยอาศัยทั้งความสามารถที่มีอยู่เดิม กิจกรรมประจำวัน และการเชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชน

การอภิปรายผลการวิจัย

1. **ความโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุ** สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุซึ่งต้องอยู่บ้านตามลำพังและจำกัดการเดินทาง ส่งผลให้เกิดความรู้สึก “โดดเดี่ยว” อย่างเด่นชัด ความหมายของความโดดเดี่ยวออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความเหงาและความรู้สึกโดดเดี่ยวจากการอยู่คนเดียว และรู้สึกว่าการต้องอยู่บ้านตามลำพัง ทำให้เกิดความรู้สึกเหงา ขาดความมีชีวิตชีวา และไร้ความหมายในชีวิตประจำวัน และ 2) การขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ภายใต้อาการควบคุมการแพร่ระบาด การพบปะผู้คนถูกจำกัดอย่างมาก ส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก แม้จะมีคนอยู่ร่วมบ้าน แต่หากขาดการสื่อสารก็ยังคงรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Peplau และ Perlman (1998) กล่าวว่าความโดดเดี่ยวเกิดจากความไม่สอดคล้องระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ต้องการและที่เป็นอยู่จริงหรือความต้องการของตัวบุคคลนั้น ทั้งนี้ผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาของ Savage และคณะ (2021) พบว่าจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมมีแนวโน้มที่จะรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในกิจวัตรประจำวันจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็มีความเสี่ยงที่จะรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นเช่นกัน ความเปลี่ยนแปลงในกิจวัตรประจำวันนี้อาจรวมถึงการไม่สามารถทำกิจกรรมที่เคยทำเป็นประจำได้ เช่น การออกไปพบปะกับเพื่อน หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และซึ่งสอดคล้องกับงานของ Wu (2020) ที่พบว่าการกักตัวและการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกโดดเดี่ยวเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญ

2. ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ทั้งด้านสังคมอารมณ์ความรู้สึก และเศรษฐกิจ โดยความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นได้สะท้อนออกมาในรูปแบบของผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิตและความรู้สึกของผู้สูงอายุ จำแนกออกได้เป็น 3 ประเด็นย่อย ดังนี้ 1) ผลกระทบด้านสังคมที่ไม่สามารถออกมาเจอบุคคลอื่นได้/ เกิดระยะห่างในครอบครัว ผู้ให้ข้อมูลอธิบายว่ามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ส่งผลให้รู้สึกขาดสัมพันธ์ภาพ ไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้ ทั้งในครอบครัวเดียวกันและบรรดาเพื่อน ๆ หรือคนรู้จัก ซึ่งส่งผลให้รู้สึกว่าเกิดระยะห่างระหว่างครอบครัว เกิดระยะห่างระหว่างสังคม ทำให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกเหงาหรือว่าโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้น 2) ผลกระทบด้านอารมณ์ความรู้สึก ความโดดเดี่ยวในช่วงโควิด-19 ส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกวิตกกังวล และขาดความอิสระในการใช้ชีวิต และ 3) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การจำกัดการเดินทางและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบด้านรายได้ รวมถึงขาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Sadang และคณะ (2021) พบว่าในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ผู้สูงอายุจำนวนมากได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรค โดยเฉพาะการห้ามออกจากบ้านและการจำกัดกิจกรรมทางสังคม ซึ่งสร้างความวิตกกังวลและเดือร้อนมากกว่าตัวโรคเอง อีกทั้งบางรายไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ต้องพึ่งพาญาติหรือเพื่อนบ้าน และเผชิญปัญหารายได้ลดลงจนต้องหาแหล่งรายได้ใหม่ในภาวะวิกฤต และจากการศึกษาของ Stuart และคณะ (2022) พบว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถเพิ่มความโดดเดี่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุเนื่องจากการจำกัดการติดต่อทางสังคมและ

การเว้นระยะห่างทางกายภาพ มาตรการต่าง ๆ ทำให้ผู้สูงอายุหลายคนถูกตัดขาดจากครอบครัวและชุมชน การแยกตัวทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดนี้ได้นำไปสู่ผลกระทบต่องานจิตและสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ

3. วิธีการเผชิญความโดดเดี่ยวในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าผู้สูงอายุที่ประสบกับภาวะโดดเดี่ยวได้พยายามเผชิญกับสถานการณ์ด้วยวิธีการหลากหลาย โดยใช้ทั้งประสบการณ์ชีวิตเดิม การทำกิจกรรมที่บ้าน การสื่อสารกับครอบครัว รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสม เพื่อรักษาภาวะจิตใจและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ดังนี้ 1) การใช้ประสบการณ์และความสามารถเดิมในการปรับตัว ผู้สูงอายุบางรายได้นำประสบการณ์จากบทบาทรุ่นก่อนหน้า เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข หรือความรู้ด้านสุขภาพ มาช่วยปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ 2) การทำกิจกรรมที่บ้านเพื่อลดความเหงา การทำงานบ้าน หรือดูแลหลานเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุเลือกทำเพื่อผ่อนคลาย ลดความรู้สึกเหงา และสร้างความรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า และ 3) การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร แม้ไม่สามารถพบหน้ากันได้ ผู้สูงอายุยังคงใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์และวิดีโอคอล เพื่อรักษาการสื่อสารและความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับ Sadang และคณะ (2021) ที่พบว่าผู้สูงอายุใช้กลยุทธ์การเผชิญปัญหาเพื่อจัดการกับความเครียดในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและการสวดมนต์เป็นวิธีที่ช่วยเสริมสร้างความสงบทางจิตใจ ขณะเดียวกัน การทำกิจกรรมเบี่ยงเบนความสนใจ เช่น การทำสวน หรือการดูโทรทัศน์ร่วมกับครอบครัว ก็ช่วยลดความรู้สึกเบื่อหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จาก Wu (2020) เน้นย้ำว่า แม้ต้องมีการเว้นระยะห่างทางกายภาพเพื่อป้องกันโรค แต่ไม่ควรเว้นระยะห่างทางสังคมหรืออารมณ์ และควรหาทางส่งเสริมความเชื่อมโยงทางสังคมในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อ การมีระบบสนับสนุน

จากครอบครัว ชุมชน และระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

4. การสร้างความสุขให้เกิดขึ้น แม้อยู่ในช่วงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่านอกจากการต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวและข้อจำกัดทางสังคม แต่ผู้สูงอายุหลายรายสามารถสร้างความสุขให้ตนเองได้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางศาสนา การช่วยเหลือผู้อื่น และการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ดังนี้ 1) การทำบุญและกิจกรรมทางศาสนา การสวดมนต์ ฟังธรรมะ และไปวัด เป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุใช้สร้างความสงบในใจ และคลายความเครียด 2) การให้ความช่วยเหลือและมีคุณค่าในชุมชน ผู้สูงอายุบางรายยังคงมีบทบาทช่วยเหลือครอบครัวและชุมชน เช่น แจกของหรือทำหน้าที่อาสาสมัคร ซึ่งช่วยให้รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และ 3) การดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียง ผู้สูงอายุหลายคนเน้นการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ปลูกผัก ทำอาหาร และดูแลบ้าน เพื่อสร้างความสุขในวิถีชีวิตที่ตนเองควบคุมได้ สถานการณ์นี้สะท้อนแนวคิดของ Peplau และ Perlman (1998) ที่ชี้ว่าเมื่อความต้องการทางสังคมของบุคคลไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม อาจก่อให้เกิดความเครียดหรือความโดดเดี่ยว ผู้สูงอายุจึงพยายามปรับตัวโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างสมดุลทางจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับที่ Sadang และคณะ (2021) ที่ระบุว่ากิจกรรมทางศาสนาและการเบี่ยงเบนความสนใจ เช่น การทำสวนหรือดูโทรทัศน์กับครอบครัว เป็นแนวทางสำคัญในการเผชิญปัญหาและสร้างความสุขในวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง

แม้ผู้สูงอายุเกิดความโดดเดี่ยวในช่วงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ด้วยการเผชิญต่อสถานการณ์การระบาดอย่างเข้าใจ ก็สามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ด้วยแนวทางที่หลากหลายและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง ด้วยวิธีการเผชิญและความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความสามารถที่มีอยู่ กิจกรรมประจำวัน และการเชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชน